



生命维持、死亡、器官移植

- 浙江大学医学院附属第二医院

- 葛子瑜

课前小测



1

导入 (10min)

Introduction



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1

知识目标:

陈述生命维持及器官移植的**核心伦理和法规**。

2

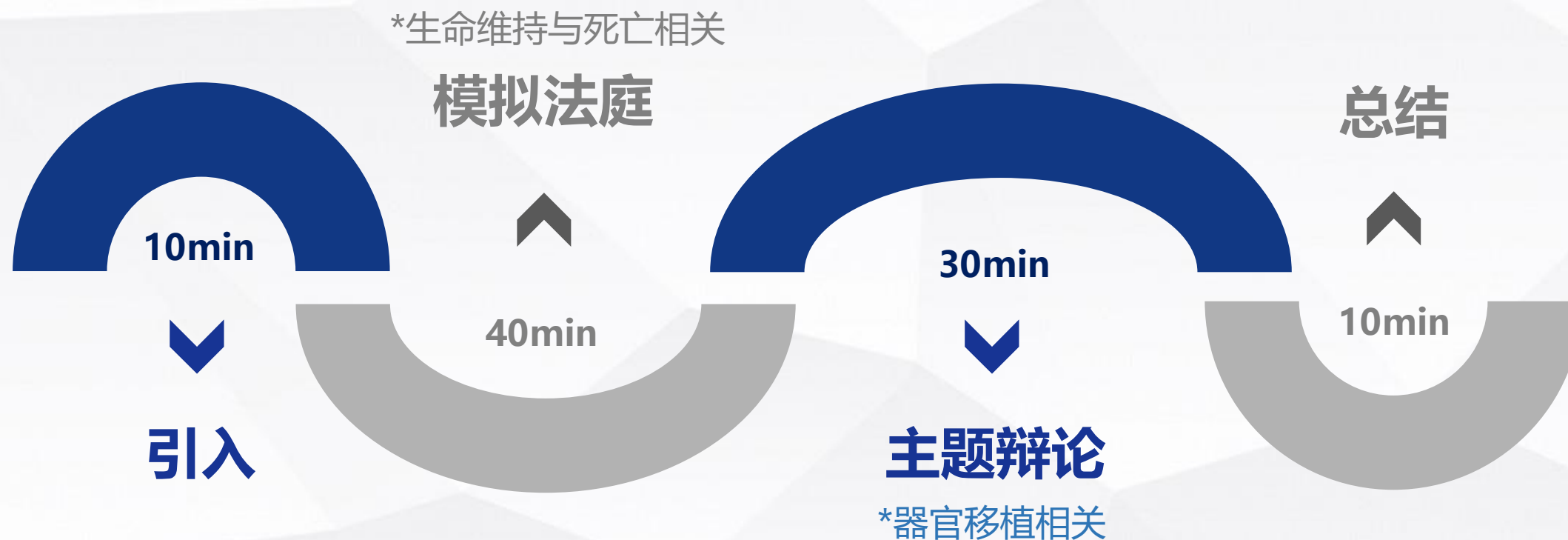
能力目标:

分析涉及终止生命维持治疗或器官移植的**典型临床案例**，识别其中的伦理困境，并**基于事实、法律和伦理原则进行初步判断**。

3

素养目标:

在伦理困境的讨论中，能结合**医患沟通视角**，展现出对患者及家属处境的**理解与共情**，并思考自身在生命终点决策和稀缺资源分配中应秉持的**人文关怀与职业责任**。



死亡： 当**循环和呼吸功能不可逆地停止**或**整个大脑（包括脑干）的所有功能均停止**时，人被视为死亡（统一死亡判定法案，1981）。

脑死亡： 脑功能完全、不可逆丧失，即昏迷无应答，失去意识，脑干反射消失，不能自主呼吸。
(The World Brain Death Project, JAMA, 2020)。

对脑死亡或神经系统死亡的诊断，可以通过能够证明**昏迷、脑干反射消失和自主呼吸停止**的临床检查来确定，包括以下情况：

- 没有证据表明对最大的外部刺激（包括伤害性的视觉、听觉和触觉刺激）有**唤醒或意识**；
 - **瞳孔**固定在中等大小或扩散的状态，对光线无反应；
 - 没有**角膜反射、头眼反射和眼前庭反射**；
 - 伤害性刺激下没有**面部运动**；
 - 双侧咽后部刺激下，没有**呕吐反射**；
 - 刺激气管深处没有**咳嗽反射**；
 - 对四肢伤害性刺激下，失去大脑介导的**运动反应**；
 - 当呼吸暂停试验的目标pH值 < 7.30 且 PaCO_2 （二氧化碳分压） $\geq 60 \text{ mm Hg}$ 时，仍然**没有自主呼吸**。
-
- **长期以来，全球各地使用的脑死亡判断标准不一，对死亡的定义和判定标准一直未能形成统一的、标准化的规范。**
 - **脑死亡需要专业人员用专业仪器在严格程序下完成，目前全国符合要求并通过脑死亡判定质控合格的医院仅有50多家。**

理解死者“最佳利益”的法律与伦理视角

《中华人民共和国民法典》第三十五条规定：

监护人应当**按照最有利于被监护人的原则履行监护职责**。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。成年人的监护人履行监护职责，应当**最大程度地尊重被监护人的真实意愿**，保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。对被监护人有能力独立处理的事务，监护人不得干涉。

- 对于失去决策能力的成年人，其**“最佳利益”的核心就是其“真实意愿”的最大化实现**。
 - 当无书面预嘱时，监护人应基于其生活方式、宗教信仰、过往言论，推断其会如何决定。

代理决策的法定顺位规则

《中华人民共和国民法典》第二十八条规定：

无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

(一)配偶；

(二)父母、子女；

(三)其他近亲属；(四)其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

《人体器官捐献和移植条例》

人体器官捐献和移植是人间大爱善行，关系人民群众生命健康，关系生命伦理和社会公平，是国家医学发展和社会文明进步的重要标志。2007年颁布施行的《人体器官移植条例》，对促进器官捐献和移植事业发展发挥了重要作用。

为了更好地保障器官捐献和移植事业健康发展，在总结实践经验的基础上，新的《人体器官捐献和移植条例》经2023年10月20日国务院第17次常务会议审议通过，自2024年5月1日起施行。新《条例》的公布和实施，对于我国人体器官捐献和移植事业发展具有深远的影响。

志愿登记人数

截至2025年11月01日

7240815

实现捐献例数

截至2025年11月01日

62284

捐献器官个数

截至2025年11月01日

193571



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

中华人民共和国国务院令

第 767 号

《人体器官捐献和移植条例》已经2023年10月20日国务院第17次常务会议通过，现予公布，自2024年5月1日起施行。

总 理 李 强

2023年12月4日

《人体器官捐献和移植条例》- 部分条目回顾

第三条 人体器官捐献和移植工作坚持**人民至上、生命至上**。国家建立人体器官捐献和移植工作体系，推动人体器官捐献，规范人体器官获取和分配，提升人体器官移植服务能力，加强监督管理。

第八条 人体器官捐献应当遵循**自愿、无偿**的原则。
公民享有捐献或者不捐献其人体器官的权利;任何组织或者个人不得强迫、欺骗或者利诱他人捐献人体器官。

第九条 具有完全民事行为能力的公民有权依法自主决定捐献其人体器官。**公民表示捐献其人体器官的意愿，应当采用书面形式，也可以订立遗嘱**。公民对已经表示捐献其人体器官的意愿，有权予以撤销。

公民**生前表示不同意**捐献其遗体器官的，任何组织或者个人**不得**捐献、获取该公民的遗体器官。

公民生前**未表示不同意**捐献其遗体器官的，该公民死亡后，其配偶、成年子女、父母可以**共同决定**捐献，**决定捐献应当采用书面形式**。

《人体器官捐献和移植条例》- 部分条目回顾

第十一条 **活体器官**的接受人限于活体器官**捐献人的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲**。

第二十条 遗体器官的分配，应当符合医疗需要，遵循**公平、公正和公开的原则**。具体办法由国务院卫生健康部门制定。患者申请人体器官移植手术，其配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲曾经捐献遗体器官的，在同等条件下优先排序。

2

模拟法庭 (40min)

Mock court



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



- 1990年2月25日： 特丽·夏沃 (27y/o) 因饮食失调导致体内钾失衡，心脏暂时停止跳动，脑部因缺氧严重受损，被诊断为持续性植物状态，需依靠胃造瘘管维持生命。
- 1990-1998年： 她的丈夫迈克尔·夏沃和父母罗伯特与玛丽·申德勒起初共同照顾她。
- 1998年：
 - 丈夫 迈克尔·夏沃作为监护人，首次向法院申请拔除营养管。他主张： 特里生前曾口头表示不愿依靠人工方式生存，尊重其自主意愿是首要原则。
 - 父母 申德勒夫妇坚决反对。他们主张： 特里仍有康复可能且可能存在意识，维持其生命是家庭的义务与希望，并质疑迈克尔的动机。
- 1998-2005年： 案件进入漫长的法律拉锯战。。。。

准备时间：10分钟

请做好准备，在模拟法庭上为你的角色“注入灵魂”，将他/她的立场、动机与情感化为己有，欢迎即兴发挥！



审判席 (3人)

- 首席法官：主持庭审流程，控制时间，引导双方辩论，宣读判决结果
- 法官A (程序/法律焦点)：负责从法律程序、证据真实性角度进行主动调查
- 法官B (事实/情理焦点)：负责从案件事实、人情事理角度进行主动调查



原告方 (3人)

- 原告律师A：陈述尊重患者生前意愿的核心观点，询问己方证人
- 原告律师B：进行交叉质询，反驳被告方论点
- 迈克尔·夏沃 (丈夫)



被告方 (3人)

- 被告律师A：陈述维护生命价值的核心观点，询问己方证人
- 被告律师B：进行交叉质询，反驳原告方论点
- 申德勒夫妇代表 (父亲/母亲)



证人席 (1人)

- 神经科专家：提供专业医学证言，解释“持续性植物状态”的医学事实

开庭陈述 (4min)→原告方举证 (6min)→被告方举证 (6min)→ 法官主动调查环节 (4min)→最终辩论与宣判 (5min)

审判席 (3人)

- 首席法官：主持庭审流程，控制时间
- 法官A (程序/法律焦点)
- 法官B (事实/情理焦点)

原告方 (3人)

- 原告律师A：陈述尊重患者生前意愿的核心观点
- 原告律师B：进行交叉质询，反驳被告方论点
- 迈克尔·夏沃 (丈夫)

被告方 (3人)

- 被告律师A：陈述维护生命价值的核心观点
- 被告律师B：进行交叉质询，反驳原告方论点
- 申德勒夫妇代表 (父亲/母亲)

证人席 (1人)

- 神经科专家：提供专业医学证言，解释"持续性植物状态"的医学事实

开庭陈述 (4分钟)

- (1分钟) 首席法官：宣布开庭，简述案件
- (1.5分钟) 原告律师A：陈述立场
- (1.5分钟) 被告律师A：陈述立场

原告方举证 (6分钟)

- (2分钟) 原告律师B 主询 迈克尔·夏沃
- (1.5分钟) 被告律师B 交叉质询
- (2分钟) 原告律师A 主询 神经科专家
- (0.5分钟) 被告律师A 交叉质询 神经科专家

被告方举证 (6分钟)

- (2分钟) 被告律师A 主询 申德勒夫妇
- (1.5分钟) 原告律师B 交叉质询
- (2分钟) 被告律师B 主询 神经科专家
- (0.5分钟) 原告律师A交叉质询 神经科专家

法官主动调查环节 (4分钟)

- (2分钟) 法官A (程序/法律焦点) 提问双方律师
- (2分钟) 法官B (事实/情理焦点) 提问申德勒夫妇及迈克尔·夏沃

最终辩论与宣判 (5分钟)

- (2分钟) 双方律师最终总结
- (2分钟) 三位法官当庭合议，基于调查环节的发现，提供关键判决意见。
- (1分钟) 宣判：首席法官宣读最终判决。

1998年：丈夫迈克尔作为监护人，首次向法院申请拔除营养管。
法院基于证据，判决支持迈克尔。营养管被首次拔除。
父母方激烈反对，提起上诉。在上诉期间，营养管被重新插上。
此举开启了“判决-上诉-暂缓执行”的循环模式。

2001年 & 2003年：**案件在佛罗里达州各级法院反复审理。**法院多次判决支持迈克尔，营养管曾两度被拔除。

- 政治力量介入：
 - 佛罗里达州议会通过“特里法案”，授权州长干预司法，下令再次重新插上营养管。
 - 案件惊动美国国会与总统，联邦层面试图通过立法将此案移交联邦法院重审。

2005年：**美国联邦最高法院多次拒绝受理此案，维持原判。**
2005年3月：营养管被最终拔除。13天后，**特里·夏沃去世。**

IN THE SUPREME COURT OF FLORIDA
CASE No. SC03-1242

In Re: THERESA MARIE SCHIAVO
Incapacitated.

ROBERT and MARY SCHINDLER,
Petitioners,
v.
MICHAEL SCHIAVO,
Respondent.

JURISDICTION BRIEF
OF
PETITIONERS, ROBERT AND MARY SCHINDLER

Petition for Discretionary Review of an Order of
the Second District Court of Appeal Case No 2D02-5394
Affirming the Trial Court's Order of Withdrawal of
Food and Water from an Incapacitated Ward

PATRICIA FIELDS ANDERSON, ESQ.
Fla. Bar No. 352871, SPN 00239231
PATRICIA FIELDS ANDERSON, P.A.
447 Third Avenue North, Suite 405
St. Petersburg, FL 33701
727 / 895-6505; 898-4903 (facsimile)
Attorney for Petitioners

为什么法院支持迈克尔？

在法律上，患者的意愿是最高准则，而迈克尔的证词在法律上足够可信，能够代表特里的意愿。

3

主题辩论 (30min)

Debate



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

“在只有一个可用肝源的情况下，以下两位患者谁应获得优先权？”

患者A：一位**65岁**的**院士**（为**国家作出巨大贡献**）。因自身免疫性肝病导致**终末期肝衰竭**。**社会支持系统良好**。根据模型评估，其移植后**5年生存率约为60%**。

正 方

患者B：一位**25岁**青年。因误服过量对乙酰氨基酚导致**急性肝衰竭，急需移植**。无基础肝病，移植后**5年生存率约为80%**。**抑郁症病史，且社会支持系统相对薄弱**。

反 方

准备时间：10分钟

辩论时间：18分钟（每队9分钟）

小组分工 {
立论陈词（1分钟）：每组推选1位同学，清晰阐述本方核心观点。
自由辩论（7分钟）：每组推选3位同学，进行论点交锋。欢迎积极发言，激烈辩论！
总结陈词（1分钟）：每组再推选1位同学，总结并升华本方立场。

“在只有一个可用肝源的情况下，以下两位患者谁应获得优先权？”

【正方】患者A：一位65岁的院士（为国家作出巨大贡献）。因自身免疫性肝病导致终末期肝衰竭。社会支持系统良好。根据模型评估，其移植后5年生存率约为60%。

【反方】患者B：一位25岁青年。因误服过量对乙酰氨基酚导致急性肝衰竭，急需移植。无基础肝病，移植后5年生存率约为80%。抑郁症病史，且社会支持系统相对薄弱。

今天，我们并非要找到一个“正确”答案，而是要理解器官分配伦理困境的核心。医学的终极挑战，往往不是在“对”与“错”之间选择，而是在“对”与“对”之间权衡。

在真实的医疗系统中，今天的辩题几乎不会以“人为主导抉择”的形式出现。

根据国家卫健委发布的《**中国人体器官分配与共享基本原则和核心政策**》，决策将由统一的计算机系统执行，匹配名单排序的主要因素包括：

- **医疗紧急度评分**

- 符合超紧急状态的肝脏移植等待者在全国分配层级优先分配。
- 不符合超紧急状态的肝脏移植等待者根据地理因素，按照 **MELD** 评分排列。
 - MELD 评分 = $0.957 \times \text{Loge 血清肌酐值 (mg/dL)} + 0.378 \times \text{Loge 血清胆红素值 (mg/dL)} + 1.120 \times \text{Loge 国际标准化比率(INR)} + 0.643$

- **地理因素**（就近原则）

- **年龄因素**（12岁以下的儿童捐献者的肝脏优先分配给12岁以下的儿童肝脏移植等待者）

- **血型匹配**（肝脏移植等待者与器官捐献者的 ABO 血型应当相同或相容；对于与器官捐献者 ABO 血型不相容的肝脏匹配，仅限于超紧急状态或 MELD/PELD 评分 ≥ 30 分的肝脏移植等待者。）

希望未来，当我们面对此类困境时，都能：**心怀对生命的敬畏，做出审慎而温暖的抉择。**

3

总结 (10min)

Summary



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

Take home message

- **知情同意权：**尊重患者自主权是医疗决策的基石。
- **最佳利益原则：**是当患者无法表达意愿时，决策的黄金标准。
 - 决策必须基于患者自身的价值观、信仰和可能的选择，而非家属或医生的偏好。其目标是最大限度地尊重患者的人格尊严与真实意愿。
- **代理决策的法定顺位与原则：**
 - 顺位规则：配偶 → 成年子女、父母 → 其他近亲属。
 - 核心原则：最大程度的尊重被监护人的真实意愿，即模拟患者本人在此情境下会如何决定，并始终以患者的最佳利益为唯一出发点。
- **器官移植的公平、公正、公开原则**
 - 公平：考虑医疗紧急度与等待时间。
 - 公正：排除不相关因素（如社会地位、经济能力）的干扰。
 - 公开：通过统一系统分配，接受社会监督，建立制度公信力。

法律和规定赋予我们权利和边界，
而伦理学赋予我们智慧和良知，
心怀对生命的敬畏，在每一个艰难的抉择中，保持审慎、共情与人文关怀。



Ethics is knowing the difference between what you
have a right to do and what is right to do.

(Potter Stewart)

课后反馈：请扫描二维码，完成tutorial反馈，请留下宝贵的意见和建议。



课程反馈二维码

撰写反思：请围绕以下两个核心问题，撰写一篇约300-500字的简短反思。

1. 立场的动摇

- 在今天的辩论中，你（或被分配）支持哪一方？现在回顾，**对方哪一个论点最让你感到纠结或动摇？**请具体描述这个观点，并分析它为何能触动你？

2. 职业的画像

- 我们看到，在临床实践中，许多伦理困境并没有技术上的“完美答案”或唯一的最优解。当未来你作为一名医生，身陷此类价值冲突与情感张力之中时，你认为**最重要的职业信念或核心态度应该是什么？**

• 请在课程结束3天内发至***邮箱***



感谢